

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Пермского края
«Городская детская клиническая поликлиника № 5»

Оптимизация диспансерного
наблюдения детей, с впервые
выявленной патологией эндокринной
системы, связанной с нарушением
питания, врачом-эндокринологом.

Руководитель проекта:

Заведующий КДО Шимова О.В.



Паспорт проекта «Диспансерное наблюдение детей с эндокринной патологией»

ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая больница № 5»

СОГЛАСОВАНО:
РЦ ПМСП
20.09.2023

Общие данные:

Заказчик: главный врач Кабанова Наталья Константиновна

Процесс: Оптимизация взятия на диспансерный учет пациентов с впервые выявленной эндокринной патологией, связанной с нарушением питания

Границы процесса:

Начало: принятие решения о постановке на диспансерный учет детей с впервые выявленной патологией эндокринной системы, связанной с нарушением питания.

Окончание: Первичный диспансерный осмотр врачом-эндокринологом с оформлением плана диспансерного наблюдения

Руководитель проекта: Шимова Ольга Викторовна- заведующий КДО – врач педиатр

Команда проекта: Зав. поликлиникой: Байбакова Л. П.

Касимова Т.А. врач эндокринолог детский

Косых А.В заведующий ЛПО 1.,

Горбунова М.В.- старшая мед сестра КДО

Цель:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1.Увеличение процента взятия на диспансерный учет детей врачом -детским эндокринологом, с впервые выявленной эндокринной патологией при нарушении питания.	20%	90%
2. Длительность ожидания приема врача-эндокринолога	25-27 дней	10 дней

Эффекты: Своевременная постановка на диспансерный учет детей врачом-детским эндокринологом

Улучшение доступности.

Обеспечение качества медицинской помощи – выполнение стандарта в рамках ДН.

Достижение complains с родителями детей по выполнению лечебно-оздоровительных мероприятий в рамках ДН.

Разработка алгоритма “Порядок организации преемственности между врачами-педиатрами участковыми и врачом-эндокринологом при диспансерном наблюдении.

Обоснование:

1. Низкий процент взятия на диспансерный учет детей с впервые выявленной патологией эндокринной системы, связанной с нарушением питания
2. Низкая полнота охвата диспансерным осмотром детей с нарушениями питания врачом -детским эндокринологом
3. Отсутствие преемственности в наблюдении детей с эндокринной патологией между врачом- эндокринологом и педиатром.
4. Ограничение доступности в приеме врача- эндокринолога.
- 5.Неудовлетворенность родителей.

Сроки:

- Защита паспорта проекта 29.11.2023
- Анализ текущей ситуации 20.09 - 01.12.2023 г разработка текущей карты 20.09.23-01.12.2023
- поиск и выявление проблем 01.10.2023- 20.11.2023
- разработка целевой карты процесса 01.11.23 - 30.12.23
- разработка «дорожной карты» реализации проекта 1.01.24 - 20.01.24
- kick-off 29.11.23
- Внедрение улучшений 26.01.23- 28.02.24
- Мониторинг устойчивости 30.10.2023 -29.05 2024
- Закрытие проекта 16.05.2024 - 30.05.2024

Карта текущего состояния

1

Пациент не имеет необходимых обследований для приёма врача-эндокринолога

3

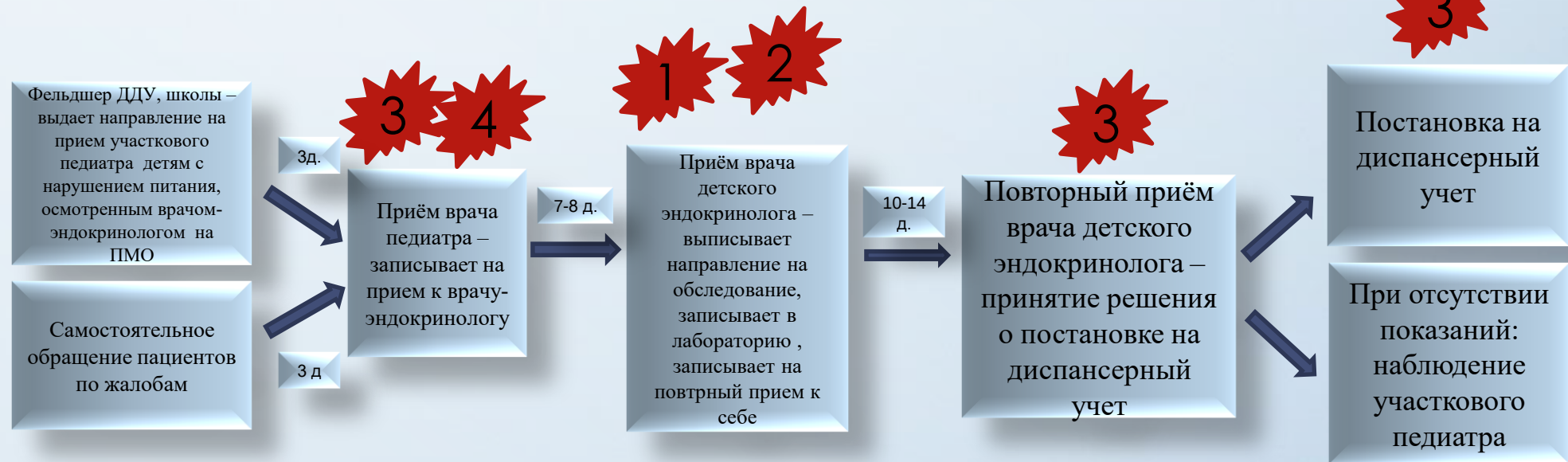
Отсутствие свободных слотов для записи

2

Записанный пациент не имеет показаний к приёму врача -детского эндокринолога

4

Не осуществлена запись “врач-врач”



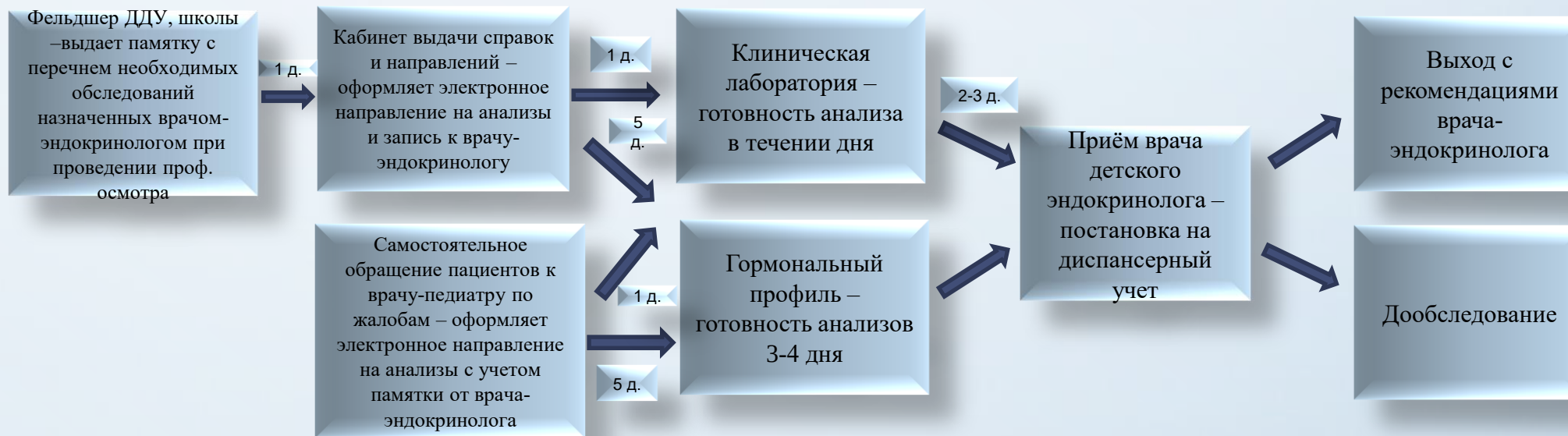
Общая продолжительность процесса 25-27 дней

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ(по системе 5 почему?)

Диспансерное наблюдение детей с эндокринной патологией



Карта целевого состояния пациента



Сокращение времени взятия на диспансерный учет за счет первичного лабораторного обследования у педиатра и обоснованного направления к врачу детскому-эндокринологу

Общая продолжительность процесса 10-11 дней

Результат анализа выявленных проблем

Проблема	Коренная причина	Мероприятия для решения проблем
Прием пациентов без необходимых обследований	Отсутствие информации для врача педиатра по обследованию для первичного приема	-разработать памятки по необходимому спектру обследования -ознакомить участковых педиатров, фельдшеров школ, ДДУ с данной информацией.
Прием пациентов при отсутствии показаний	Не разработаны четкие показания к приему врача-детского эндокринолога	-разработать показания к приему специалиста -информировать педиатров о показаниях к приему врача -детского эндокринолога
Длительное время ожидания приема врача-эндокринолога	-Отсутствие достаточного количества бирок -Прием не по показаниям -Прием с целью оформления направлений для первичного обследования -» Недоход « пациентов по предварительной записи - 36- часовая рабочая неделя	- -предварительный обзвон пациентов, информирование об отмене записи на прием с последующим освобождением занятых слотов и согласование с пациентом даты следующей явки. - увеличение рабочего времени специалиста: установление 39- часовой рабочей недели для специалистов.
Низкий процент взятия на диспансерный учет детей, с впервые выявленной патологией эндокринной системы, связанной с нарушением питания	- Врач- эндокринолог не ставил на диспансерный учет детей с ДЗ: Ожирение 1-2 степени.	согласно проекту « Здоровье нации», приказа МЗПК от 31.03.2022 г « О показателях результативности деятельности медицинских организаций - фондодержателей Пермского края и критерии их оценки в 2022 году» в 85% случаев дети с впервые выявленной патологией эндокринной системы должны состоять на диспансерном учете .Утверждение порядка исполнения данного документа с целью достижения целевого показателя.

План мероприятий

Мероприятия	Сроки исполнения
-разработать памятки по необходимому спектру обследования необходимых для консультации специалиста - ознакомить участковых педиатров, фельдшеров школ, ДДУ с данной информацией.	Январь – февраль 2024
- разработать показания к приему специалиста -информировать педиатров о показаниях к приему врача - детского эндокринолога	Январь 2024
- увеличение рабочего времени специалиста: установление 39- часовой рабочей недели для специалистов (инцидент 38) - Утверждение порядка исполнения показателей с целью достижения целевого показателя.(согласно проекту « Здоровье нации» в 90% случаев дети с впервые выявленной патологией эндокринной системы должны состоять на диспансерном учете)	Ноябрь 2023 Январь 2024 год

Порядок организации преемственности между врачами участковыми и врачом детским эндокринологом

Утверждаю

Заместитель главного врача

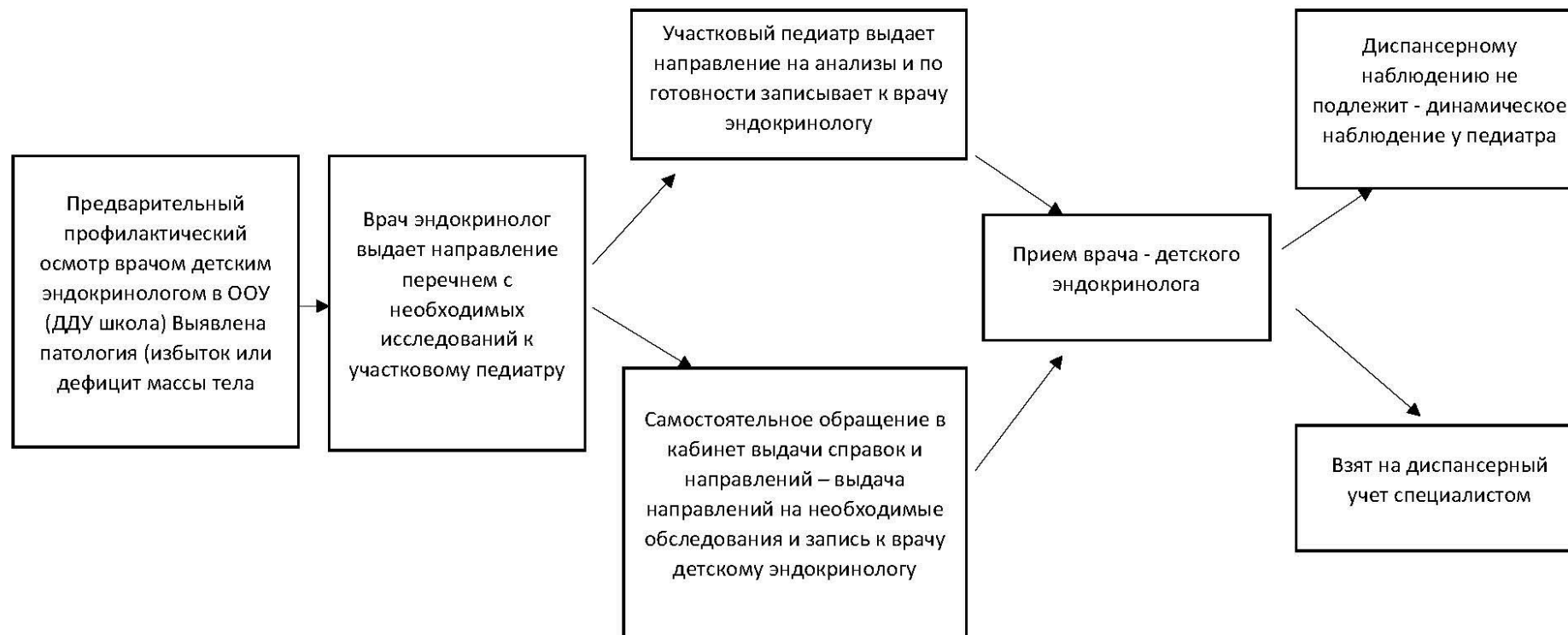
Перминова О.А.



Согласовано

РЦ ПМСП

18.07.2024



Достижение целевых показателей

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	За 6 мес. 2024	За 9 мес. 2024
1. Увеличение процента взятия на диспансерный учет детей врачом-детским эндокринологом, с впервые выявленной эндокринной патологией при нарушении питания.	20%	90%	94%
2. Длительность ожидания приема врача-эндокринолога	25-27 дней	10 дней	2-5 дней

Направление в кабинет выдачи справок:

Ф.И.О.пациент

осмотрен профилактически в школе врачом-эндокринологом

ФИО. врача

выставлен предварительный Ds:

Необходимо детальное лабораторно-инструментальное обследование ПЕРЕД ПРИЕМОМ ЭНДОКРИНОЛОГА:

Биохимический анализ крови

- ГЛЮКОЗА ВЕНОЗНОЙ ПЛАЗМЫ
- Лип.профиль (ТРИГЛИЦЕРИДЫ, ХОЛЕСТЕРИН ОБЩИЙ, ЛПВП, ЛПНП)
- АЛТ, АСТ
- HbA1c
- КАЛЬЦИЙ ОБЩИЙ

Горм.профиль:

ТТГ ПРЛ

УЗИ

- щитовидной и паращитовидных желез
- органов бр полости (подготовка)
- органов малого таза(подготовка)
- надпочечников
- Rg Кистей и черепа (Костный Возраст)

Явка на прием к эндокринологу с ребенком по записи (указывается дата и время записи)

Показания к консультации врача- эндокринолога , для педиатров:

- избыток массы тела (по SDS более «+2»(калькулятор Auxology)
- низкорослость (по SDS менее «-2»(калькулятор Auxology)
- изменения со стороны щитовидной железы (по УЗИ объем выше нормы по ВОЗ соответственно S м2, изменения в гормон.профиле и тп)
- появление признаков полового развития у девочек до 8л, у мальчиков до 9 л
- .
- отсутствие признаков полового созревания: увеличения груди у девочек старше 12л6м. отсутMe старше 15лет; отсутствие увеличения тестикул у мальчиков старше 13л6мес
- судорог в мышцах ног, частых переломах
- подозрением на сахарный диабет(наличие клинических признаков)
- изменения в анализах крови на глюкозу при отсутствии клинических признаков сахарного диабета

Принципы организации питания детей с избыточным весом:

1. Соблюдение режима питания. Всё, что съедено до 12 часов дня, идёт на обеспечение организма энергией.
Всё, что съедено после 14.00 – откладывается в виде жира.
Вечерний приём пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна.
2. Соблюдение правил обработки продуктов:
Недопустимо обжаривание, копчение продуктов, особенно при использовании некачественного или уже ранее использовавшегося растительного или сливочного масла.
Рекомендуется пищу готовить на пару, тушить, варить.
3. Постепенное, а не одномоментное исключение из питания высококалорийных продуктов позволяет избежать возникновения «диетической депрессии», которая неизбежно возникает при резкой смене привычного стиля еды.
4. Настоятельно не рекомендуется, есть на ходу, стоя, перед телевизором, компьютером и пр.
5. Есть рекомендуется медленно, использовать для сервировки «полупорционные» тарелки.
6. В первое время, когда пищевые ограничения даются с трудом, следует избегать ситуаций, которые способствуют перееданию, например, походы в гости, кафе, приём гостей.
7. Все пищевые ограничения рекомендовано распространять на всю семью.
8. Дома не должны находиться продукты, которые запрещены ребёнку.
9. Не приучать ребёнка «заедать» стресс. Ребёнок имеет право на негативные эмоции.
Важно научить его правильно реагировать на стресс и предложить отличные от приёма пищи способы расслабления: прогулки, танцы, занятия спортом, музыка, рисование, творчество (лепка, вязание) и др.
10. Рекомендованы и являются обязательными физические упражнения аэробного типа (игровые виды спорта, велосипед, ходьба в быстром темпе, плавание, танцы, в том числе спортивные).
11. Категорически противопоказаны травмоопасные виды спорта: борьба, бокс, карате, тяжёлая атлетика.

Внимание!

Запрещается указывать ребёнку на недостатки и /или физические особенности его фигуры, связанные с избыточным весом. Недопустимы насмешки, прозвища, пусть даже безобидные. Недопустимым является изоляция ребёнка от детских праздников и массовых мероприятий. Перед праздником или походом в гости следует тактично напомнить ребёнку об умеренном потреблении сладкого, и ни в коем случае не напоминать и не одёргивать его в присутствии других детей, значимых взрослых. Следует объяснить ребёнку, что правильное питание – это основа здорового образа жизни, а не ограничение родительской любви.

Спасибо за внимание